

Matriz de Riscos do Sistema

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Risco	Plano de Mitigação (Prevenção)	Plano de Contingência (Resposta)
R-01	Falha de Integração com o PEC/Sistemas SUS	Integração	3	3	9	Utilizar API/Padrões abertos: Realizar testes de integração rigorosos (stress tests) desde o início do desenvolvimento, garantindo conformidade com os padrões de dados do Cartão SUS (mencionado no RF).	Se a integração falhar, manter a sincronização de dados cadastrais manual e notificar a equipe técnica do PEC para resolução.

R-02	Instabilidade Crônica do Sistema (Queda)	Infraestrutura	3	3	9	Modo Offline/Buffer: Desenvolver o sistema com capacidade de operar em modo offline temporário, salvando os registros de chegada (check-in) em um buffer local.	Se o sistema cair, ativar o Modo Manual Rápido: o sistema imprime um número simples (senha) para a fila física e os dados são inseridos digitalmente assim que o sistema retornar.
R-03	Inconsistência de Dados Cadastrais	Qualidade	2	3	6	Validação Inteligente: Implementar autocomplete e verificação de formato (ex: 15 dígitos para o Cartão SUS) e validação de existência ao buscar o paciente.	Criar uma função de "Merge de Pacientes" para que a recepção possa corrigir ou unificar cadastros duplicados ou inconsistentes.

R-04	Rejeição por Mudança de Fluxo (Recepcionistas)	Usabilidade	2	2	4	Priorizar a simplicidade operacional. Realizar treinamento prático antes do go-live.	Criar um canal de suporte dedicado e promover "campeões" de uso na recepção para auxiliar os colegas mais resistentes.
R-05	Falha no Hardware (Impressoras/Painel)	Infraestrutura/Equipamento	3	2	6	O painel deve ser acessível por qualquer navegador ou dispositivo móvel na rede local (Web-based), permitindo o uso de um tablet/PC substituto.	Se o painel falhar, o recepcionista deve ter a opção de chamar o paciente por alto-falante, usando a ficha eletrônica como referência.